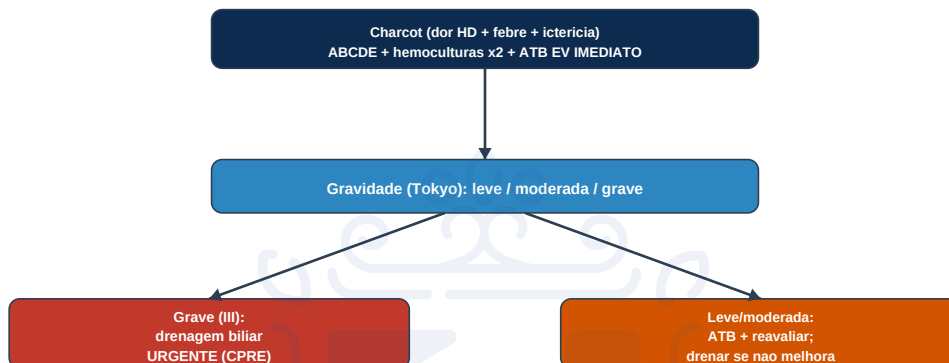


COLANGITE AGUDA — ATB + DRENAGEM BILIAR

FLUXOGRAMA — OBSTRUÇÃO + INFECÇÃO

COLANGITE — RESSUSCITAR, ATB E DRENAR



DEFINIÇÃO E CLÍNICA

OBSTRUÇÃO + INFECÇÃO BILIAR

- Infecção do sistema biliar por obstrução do fluxo (coledocolitíase, estenose, neoplasia) com infecção ascendente — potencialmente grave
- TRIÁDE DE CHARCOT: dor em HD/epigástrio + febre/calafrios + icterícia (ausência de um componente NÃO afasta)
- PÊNTADE DE REYNOLDS (grave): Charcot + hipotensão/choque + alteração do nível de consciência
- Fatores: idade avançada, colelitíase, CPRE/prótese prévias, estenoses, neoplasia periampular, imunossupressão
- Laboratório: leucocitose variável, colestase (BT, FA, GGT), PCR elevada

GRAVIDADE (TOKYO) E URGÊNCIA DA DRENAGEM

Grau	Critério / drenagem
I — Leve	Sem critérios de gravidade -> ATB e observação; drenar se não regredir
II — Moderada	Alto risco (leucocitose intensa, febre alta, BT elevada, idade) -> drenagem precoce se sem melhora em 24-48h
III — Grave	Disfunção orgânica (CV, neuro, resp, renal, coagulopatia) -> drenagem URGENTE + reanimação

CONDUTA IMEDIATA NO PS

TEMPO É BILE INFECTADA

- ABCDE: O2 se SatO2 < 94%; monitorização; acesso calibroso + reposição volêmica (protocolo de sepse)
- HEMOCULTURAS x2 antes do ATB (se não atrasar a terapia)
- ATB empírico EV IMEDIATO (não aguardar imagem para iniciar)
- Analgesia (Dipirona/Paracetamol; opioide com cautela hemodinâmica) + antiemético
- Internar TODOS; UTI se disfunção orgânica/choque/necessidade de vasopressor

ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA

Rx COBRIR GRAM-NEGATIVOS ENTÉRICOS (± ANAERÓBIOS)

Opção 1 (maioria): Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6-8/8h

Opção 2: Ceftriaxona 1-2 g EV/dia + Metronidazol 500 mg EV 8/8h

Opção 3 (choque/risco ESBL/nosocomial): Meropenem 1 g EV 8/8h

Alergia grave a beta-lactâmico: Ciprofloxacino 400 mg EV 12/12h + Metronidazol 500 mg EV 8/8h

Duração 4-7 dias após drenagem adequada; descalonar conforme cultura; ajustar à função renal

Pediatria: Ceftriaxona 50-75 mg/kg/dia (máx 2 g/dose); transferir para centro com CPRE pediátrica

DRENAGEM BILIAR — DEFINITIVA

TIMING GUIADO PELA GRAVIDADE

- CPRE é o método de ESCOLHA (papilotomia, extração de cálculo, stent); melhores resultados nas primeiras 24-48h
- Grau III (grave): drenagem URGENTE assim que minimamente estabilizado (não adiar pela instabilidade não corrigida)
- Grau II: ATB + reavaliar; drenagem precoce se sem melhora em 24-48h
- Grau I: tratamento clínico e observação; drenar se não houver regressão
- Drenagem percutânea trans-hepática se CPRE inviável (anatomia alterada, falha técnica, instabilidade extrema)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com Charcot (dor HD + febre + icterícia); Reynolds (choque/confusão): ____.
- Sinais vitais ____; BT/FA/GGT ____; leucócitos ____; lactato ____; Tokyo grau ____.
- Hemoculturas x2 ____; ATB ____ iniciado às ____; volume EV ____; vasopressor ____.
- Solicito: () CPRE URGENTE (Grade III) () CPRE 24-48h (Grade II sem melhora) + UTI conforme disfunção orgânica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com colangite aguda grave (disfunção orgânica/choque). Após início de ATB e ressuscitação, qual a conduta determinante para o prognóstico?

- A) Aguardar 72h de antibiótico antes de qualquer intervenção
- B) Drenagem biliar urgente (CPRE) assim que minimamente estabilizado
- C) Colectomia aberta imediata
- D) Apenas observação clínica
- E) Repetir hemoculturas seriadas antes de drenar

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual a sequência correta na conduta imediata da colangite aguda no PS?

- A) Drenar primeiro, depois antibiótico
- B) Hemoculturas + antibiótico EV imediato + ressuscitação, com drenagem biliar conforme a gravidade
- C) Apenas analgesia e alta
- D) Antibiótico oral ambulatorial
- E) Aguardar colangiorressonância antes de qualquer medida

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual esquema antibiótico empírico é adequado para a maioria dos casos de colangite aguda comunitária?

- A) Azitromicina oral
- B) Piperacilina-tazobactam EV (ou ceftriaxona + metronidazol)
- C) Vancomicina isolada
- D) Nenhum antibiótico
- E) Fluconazol

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

A pêntrade de Reynolds (colangite grave) acrescenta à tríade de Charcot:

- A) Colúria e acolia
- B) Hipotensão/choque e alteração do nível de consciência
- C) Prurido e emagrecimento
- D) Vômitos e diarreia
- E) Massa palpável

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o método de escolha para a drenagem biliar na colangite aguda?

- A) Colectomia laparoscópica
- B) CPRE (colangiopancreatografia endoscópica)
- C) Drenagem percutânea de rotina
- D) Laparotomia exploradora
- E) Sonda nasobiliar às cegas

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na colangite grave (Grade III), a drenagem biliar urgente (CPRE) assim que o paciente esteja minimamente estabilizado é determinante — não se deve adiar pela instabilidade não corrigida. ATB e ressuscitação são adjuvantes.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A conduta imediata é hemoculturas x2 + antibiótico EV imediato + ressuscitação volêmica (protocolo de sepse), com a drenagem biliar programada conforme a gravidade (urgente no grau III).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Piperacilina-tazobactam (ou ceftriaxona + metronidazol) cobre os Gram-negativos entéricos e anaeróbios típicos; carbapenêmico (meropenem) reserva-se a choque/risco de ESBL/infecção nosocomial.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A pêntrade de Reynolds = tríade de Charcot (dor HD + febre + icterícia) + hipotensão/choque + alteração do nível de consciência, indicando colangite grave (Grade III).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A CPRE é o método de escolha para drenagem biliar (papilotomia, extração de cálculo, stent), com melhores resultados nas primeiras 24-48h; a percutânea fica para quando a CPRE é inviável.

SM24
Suporte ao Plantão Médico